

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
טטיאנה מזרסקי
משה פסל
מיכאל מלכיאלי
יאסר חוג'יראת
אחמד טיבי
ירון לוי

פ/25/6367

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מינוי ועדה ציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השנייה), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 9 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9 –

(1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) מדי שנה תגדל עלות סל שירותי הבריאות בשיעור שלא יפחת מ-1.65% מעלות סל שירותי הבריאות בשנה הקודמת." ;

(2) בסעיף קטן (ג), לפי "בכל אחת" יבוא "נוסף על האמור בסעיף קטן (ב1)",.

הוספת פרק 1א 2. אחרי סעיף 52 לחוק העיקרי יבוא :

"פרק 1א : ועדת סל השירותים

הגדרות – פרק 1א 52א. בפרק זה –

"טכנולוגיה" – תרופה, מכשיר רפואי, תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981, ציוד רפואי, פרוצדורות רפואיות למניעה, לאבחנה, לטיפול או לשיקום ;

"טכנולוגיה מוצעת" – טכנולוגיה שהוגשה הצעה להכלילה בסל שירותים לפי סעיף 52ח ;

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מישהו שהוא הסמיך לעניין זה;

"סל השירותים" – סל שירותי הבריאות הכלול בתוספת השנייה;

"עלות של טכנולוגיה" – העלות השנתית הנדרשת להוספת טכנולוגיה לסל השירותים, המחושבת כמנה המתקבלת ממכפלת כל הגורמים שלהלן:

(1) עלות טיפול באדם באמצעות הטכנולוגיה;

(2) מספר הטיפולים לאדם על פי ההתוויה הרשומה, ולגבי טכנולוגיה שטרם נרשמה – על פי המופיע בתיק הרישום;

(3) מספר האנשים שקיים צפי שישתמשו בטכנולוגיה זו במהלך שנה;

"עלות כוללת" – העלות של הטכנולוגיה המוצעת בניכוי אחד או יותר מאלה, לפי העניין:

(1) עלות הטכנולוגיה שכבר כלולה בסל השירותים, ותוחלף על ידי הטכנולוגיה המוצעת;

(2) ההוצאות שצפויות בשנה בסל השירותים אם הטכנולוגיה המוצעת לא תתווסף לסל השירותים.

מינוי חברי ועדת הסל והרכבה 52.ב. (א) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, ימנה ועדה ציבורית קבועה בת 19 חברים להרחבת השירותים הכלולים בסל השירותים (להלן – ועדת הסל), ואלה הם:

(1) ארבעה רופאים מומחים בעלי התמחויות שונות בתחומי הרפואה הקלינית; אחד מהם יהיה רופא בעל מומחיות ברפואה פנימית, רפואת משפחה, רפואת ילדים, גריאטריה או רפואת נשים, ובעל ניסיון ברפואה ציבורית, והוא יהיה היושב ראש;

(2) שלושה מומחים בתחומי מינהל רפואי, כלכלת בריאות ובריאות הציבור, שאינם עובדי המדינה;

(3) ארבעה נציגי קופות החולים – נציג אחד לכל קופה;

(4) נציג אחד של ההסתדרות הרפואית בישראל;

(5) חמישה נציגי ציבור מתחומים אלה: אתיקה, חברה ודת; מהם אחד נציג עמותת חולים או ארגון אזרחי שאינם מייצגים קבוצת חולים פרטנית;

(6) נציג מקרב עובדי משרד הבריאות;

(7) נציג מקרב עובדי משרד האוצר.

(ב) מספר עובדי המדינה בקרב חברי ועדת הסל לא יעלה על שליש; לעניין סעיף קטן זה לא יבוא במניין עובדי המדינה רופא שהוא עובד בית חולים ממשלתי שמונה כחבר ועדה לפי סעיף קטן (א)(1).

(ג) תקופת כהונתו של חבר ועדת הסל תהיה ארבע שנים, וניתן למנותו לתקופת כהונה נוספת של שנתיים בלבד.

ניגוד עניינים 52ג. (א) לא יתמנה כחבר ועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הסל לפי חוק זה ובין עניין אישי או עיסוק או תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר ועדת הסל יימנע מהשתתפות בדיון או מהצבעה בישיבות הוועדה אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הסל לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה.

(ג) התברר לחבר ועדת הסל כי הנושא שיידון בוועדה עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב

ראש הוועדה.

פגיעת כהונה 52ד. חבר ועדת הסל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר; התפטר יושב ראש ועדת הסל במסירת מכתב התפטרות לשר, ימונה ממלא מקום מקרב חברי ועדת הסל עד למינוי יושב ראש קבוע;

(2) הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הנוגעת לתחום המומחיות שבשלו מונה כחבר בוועדת הסל;

(3) אם נתמנה לפי סעיף 52ב(א)(2) או (5) – הוא הפך להיות עובד מדינה או עובד בקופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994³;

(4) אם נתמנה בשל היותו עובד, חבר או ממלא תפקיד בגוף מסוים – סיים עבודתו, או חדל להיות חבר או למלא תפקיד באותו גוף.

העברה מכהונה 52ה. השר רשאי להעביר מכהונתו את חבר ועדת הסל לפני תום תקופת כהונתו אם התקיים אחד מאלה:

(1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;

(2) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או בשל עבירה הנוגעת לתחום המומחיות שבשלו מונה כחבר בוועדת הסל.

מניין חוקי והחלטות 52ו. (א) המניין החוקי בישיבות ועדת הסל לא יפחת משני שליש מחבריה.

(ב) החלטות ועדת הסל יתקבלו בהסכמת רוב המשתתפים.

סדרי עבודה 52ז. (א) ועדת הסל תנהל את דיוניה מדי שנה באופן שיאפשר להוסיף את הטכנולוגיות המומלצות על ידה לסל השירותים בתחילת שנת התקציב העוקבת.

³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

(ב) ועדת הסל תחל את דיוניה לא יאוחר מ-1 בספטמבר ותגיש את המלצותיה המנומקות לגבי שנת התקציב העוקבת למועצת הבריאות להערותיה לא יאוחר מ-1 בנובמבר; ועדת הסל תעביר לשר את ההמלצות כאמור, בצירוף הערות מועצת הבריאות לפי סעיף 52ג, לא יאוחר מ-30 בנובמבר.

(ג) יושב ראש ועדת הסל רשאי, מיוזמתו או לבקשת חברי ועדת הסל, לזמן מומחה או כל אדם אחר לבוא לפני ועדת הסל ולהעיד בתחום מומחיותו או בכל עניין אחר או להציג מסמכים או מוצגים אחרים שברשותו.

(ד) יושב ראש ועדת הסל רשאי לדרוש ממוסדות המדינה או מגופים המתקצבים על ידי המדינה, לרבות קופות החולים, מסמכים או נתונים הנמצאים בידיהם לצורך דיוני ועדת הסל; מי שנדרש למסור מסמכים או נתונים כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה בהקדם.

(ה) יושב ראש ועדת הסל יקבע את סדר היום של ישיבות ועדת הסל ומועדיהן, והכול בכפוף ללוחות הזמנים המפורטים בחוק זה.

(ו) בחודש יוני, בכל שנה, ועדת הסל תתכנס פעם נוספת לדון בהכללת טכנולוגיות מוצעות שאינן דורשות הוספה לעלות סל השירותים, בהתאם לרשימה שתועבר אליה על ידי המנהל לאחר שבוצעה לגביהן הערכה לפי סעיף 52ח, ולאחר שהועברו להערות מועצת הבריאות; הוועדה תעביר את המלצותיה לפי סעיף קטן זה לשר הבריאות בצירוף הערות מועצת הבריאות לא יאוחר מיום 20 ביוני, כדי לאפשר את הוספת הטכנולוגיות לסל השירותים באותה שנה.

הגשת הצעה	52ח. (א) כל גורם רשאי להגיש הצעה להכללת
להכללת טכנולוגיה	טכנולוגיה בסל השירותים, בהתאם לפרטים
בסל השירותים	שיופיעו בטופס שיפרסם המנהל; טופס כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

(ב) לא היו בידי מגיש ההצעה להכללת הטכנולוגיה בסל השירותים כל הפרטים הנדרשים בטופס כאמור בסעיף קטן (א), יציין בטופס במפורש את הפרטים שאין בידו, ורשאי המנהל להשלים את הפרטים האמורים, ככל שהם נמצאים בידי המנהל.

הערכת טכנולוגיות 52ט. (א) כל הצעה שתוגש לפי סעיף 52ח(א) תוערך על ידי המנהל.

(ב) משרד הבריאות יקבע אמות מידה להערכת הטכנולוגיות המוצעות לשם ריכוזן בספר הטכנולוגיות כאמור בסעיף קטן (ה); המנהל יעביר לוועדת הסל את הטכנולוגיות המוצעות העומדות באמות המידה.

(ג) המנהל יפנה לכל גורם שימצא לנכון לשם קבלת מידע הדרוש לצורך הערכת הטכנולוגיות המוצעות, ובכלל זה מסמכים, נתונים, הערכות וחוות דעת; מי שנדרש למסור מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה בהקדם.

(ד) במקרה שהערכת טכנולוגיה מוצעת שהכין המנהל מתבססת על נתון שונה מהנתונים שנכללו בהצעה להכללת אותה טכנולוגיה, תועבר הערכת המנהל למגיש ההצעה, אשר יגיש בתוך 21 יום תשובה מנומקת, ככל שישנה, ורק לאחר מכן יגבש המנהל את הערכתו הסופית לגבי אותה טכנולוגיה; בהערכתו הסופית המנהל רשאי לחלוק על נתוני המציע ולכלול בספר הטכנולוגיות נתונים שונים מאלו שהגיש המציע.

(ה) המנהל יסיים עד ל-1 בספטמבר את תהליך ההערכה הראשונית לגבי טכנולוגיות שהוצעו עד 15 ביולי של כל שנה, וירכז את הערכותיו בכרך (להלן – ספר הטכנולוגיות), אשר יועבר לחברי ועדת הסל ויפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות טרם תחילת דיוני הוועדה.

(ו) ההערכות של הטכנולוגיות שיכללו בספר הטכנולוגיות לפי סעיף קטן (ה) יהיו במבנה אחיד

ביחס לכלל הטכנולוגיות ובשפה פשוטה, בהירה ומובנת לחברי ועדת הסל.

(ז) יושב ראש ועדת הסל רשאי להוסיף לדיוני ועדת הסל טכנולוגיות שלא נכללו בספר הטכנולוגיות, אם סבור כי הן בעדיפות גבוהה לפי השיקולים האמורים בסעיף 52א, ובלבד שהערכתן הסתיימה טרם סיום עבודת הוועדה.

תפקידי הוועדה 52. (א) ועדת הסל תקבע את סדרי העדיפויות בין הטכנולוגיות הכלולות בספר הטכנולוגיות, או שהועברו לפי סעיף 52ט(ז) לצורך הכללתן בסל השירותים ותגיש את המלצותיה לאישור שר הבריאות, בצירוף הערות מועצת הבריאות.

(ב) ועדת הסל תהא מוסמכת לדון ולהמליץ בפני השר על גריעת טכנולוגיות הכלולות בסל השירותים, באופן מלא או חלקי; שווי מימון הטכנולוגיות שנגרעו יופנה להכללת טכנולוגיות חדשות.

שיקולים בקבלת החלטה 52א. בהחלטתה לפי סעיף 52, תביא ועדת הסל בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

- (1) הצלת חיים או מניעת תמותה;
- (2) מניעת מחלה;
- (3) הארכת חיים ותוחלת חיים;
- (4) שיפור איכות חיים הצפויה לחולה;
- (5) יעילות בטיפול במחלה;
- (6) קיום חלופה טיפולית ויעילות יחסית לחלופה;
- (7) קיום ניסיון בארץ ובעולם בשימוש בטכנולוגיה המוצעת;
- (8) עלות כלכלית ברמת הפרט וברמה הלאומית, תוך השוואה לטכנולוגיות הכלולות בסל השירותים שמהוות חלופות טיפוליות במחלה שבה מטפלת הטכנולוגיה המוצעת;

(9) מספר החולים שצפויים לעשות שימוש בטכנולוגיה המוצעת;

(10) התועלת הצפויה מהכללת הטכנולוגיה המוצעת בסל השירותים, לטווח קצר וארוך;

(11) העלות הכוללת של הטכנולוגיה המוצעת.

תקציב הטכנולוגיות 52יב. הוועדה תגבש את המלצותיה לפי סדרי העדיפויות שקבעה בין הטכנולוגיות עד מגבלת סכום התקציב שייעדה הממשלה להוספת טכנולוגיות לסל השירותים, בהצעת התקציב לשנה העוקבת.

הערות מועצת הבריאות 52יג. (א) מועצת הבריאות תעביר ליושב ראש ועדת הסל את הערותיה המנומקות תוך שבעה ימים ממועד קבלת המלצות הוועדה כאמור בסעיף 52ז(ב) לחוק זה, ולא יאוחר מ-15 בנובמבר.

(ב) מועצת הבריאות רשאית להורות לוועדת הסל לחזור ולקיים דיון נוסף בהמלצותיה, כולן או חלקן.

(ג) הורתה מועצת הבריאות לקיים דיון נוסף כאמור בסעיף קטן (ב), תתכנס ועדת הסל ותקיים את הדיון הנוסף תוך שבעה ימים מיום החלטת מועצת הבריאות.

סודיות 52יד. חבר ועדת הסל לא יעשה שימוש במידע, לרבות נתונים מסחריים או במסמכים שהגיעו אליו עקב תפקידו, ולא יגלה אותם לאחר, אלא לצורך ביצוע תפקידו מכוח חובה על פי דין למסור מידע או בהתאם להוראת בית המשפט.

פומביות הדיון ופרסומו 52טו. (א) דיוני ועדת הסל יהיו פומביים.

(ב) יושב ראש ועדת הסל רשאי להורות על הגבלת פרסום תוכן דיון בעניין מסוים, כולו או מקצתו, או קיום דיון בעניין מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות אם ראה בכך צורך בשל טעם מהטעמים שלהלן:

(1) לשם הגנה על פרטיותו של אדם;

(2) הדיון הפומבי עלול להרתיע מלהופיע בפני ועדת הסל;

(3) הדיון הפומבי עלול לפגוע בסוד מסחרי או סוד מקצועי.

(ג) סיכומי ישיבות הוועדה יפרסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מתום הישיבה.

(ד) ההמלצות המלאות של ועדת הסל, לרבות נימוקים, שיקולים בקביעת סדרי עדיפויות ופרוטוקולים של דיוניה, למעט שמות הדוברים, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות לא יאוחר מ-45 ימים מיום הגשת המלצות ועדת הסל לאישור הממשלה.

תקנות 52טז. שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצועו של פרק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את דרכי עבודתה של הוועדה הציבורית להרחבת סל הבריאות הממליצה לשר הבריאות על הטכנולוגיות הראויות להכללה בסל שירותי הבריאות שלו זכאים תושבי ישראל מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי). ההתפתחויות המהירות בתחום הרפואה מחייבות לעדכן בהתאם את שירותי הבריאות הכלולים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. מדי שנה מוכחות כיעילות טכנולוגיות רפואיות חדשות הכוללות תרופות, בדיקות, פרוצדורות רפואיות, חיסונים, אביזרים ועוד. טכנולוגיות חדשות אלו מאפשרות הארכת חיים, שיפור איכות החיים וסיוע לחולים שלפני כן לא היה מזור למחלתם. חוק ביטוח בריאות ממלכתי לא קובע מנגנון להוספת טכנולוגיות לסל השירותים למעט סמכות שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, כמו גם מתן סמכות לשר הבריאות להוסיף שירותים בהינתן מקור תקציבי או כאשר אין תוספת עלות להוספת שירות זה, וסמכות מועצת הבריאות ליעץ לשר לעניין זה.

מאז שנת 1997, חוק התקציב קובע בכל שנה סכום אשר מיועד להוספת טכנולוגיות רפואיות לסל השירותים בתוספת השנייה במטרה לתת מענה להתקדמות בתחומי הרפואה.

מדי שנה מוצעות כ-400 טכנולוגיות חדשות להכללה בסל השירותים. בפועל התקציב המיועד למטרה זו מספיק להכללה של חלק קטן יחסית של הטכנולוגיות המוצעות. על מנת לבחור את הטכנולוגיות הראויות ביותר ממנה שר הבריאות מדי שנה ועדה ציבורית אשר תמליץ בפניו על הטכנולוגיות הראויות להיכלל בסל.

הוועדה פועלת מעל שני עשורים, אולם הרכב חבריה, סדר עבודתה, השיקולים המנחים ותהליכים חיוניים נוספים אינם מוסדרים בחקיקה ומתבססים על נוהל משרד הבריאות משנת 2009. זאת למרות

הכרעות הוות גורל העומדות בפני ועדת הסל, והלחצים הרבים מצד גורמים פרטיים ולעיתים אף ממשלתיים בפניהם היא נתונה.

הצעה זו מעגנת את דרכי עבודתה של ועדת הסל, מינוי חבריה, קביעת דרכי בקרה וקווים מנחים לשיקוליה של ועדת הסל במטרה לייעל את עבודת הוועדה. הצעה זו תאפשר לשחרר את הוועדה מחשיפה ללחצים חיצוניים ולהבטיח את עבודתה בהתאם לשיקול דעת רפואי וחברתי בלבד המחויב לתועלת החולים והציבור בישראל. הצעה זו מבטיחה שקיפות בדרכי עבודת הוועדה באופן שיאפשר ביקורת ציבורית בלי להפריע או להתערב בעבודת הוועדה גופה.

סדרי העבודה המוצעים יאפשרו לקבל את המלצות הוועדה במועד, תוך עמידה באמות מידה ראויות של שקיפות וקבלת החלטות ציבוריות הנוגעות לכל תושב בישראל. נוסף על כך, משך הכהונה המוצע יאפשר לחברי ועדת הסל להתמקצע בעבודת הוועדה ולתרום תרומה משמעותית יותר לקבלת ההחלטות מכפי שמתאפשר להם כיום לנוכח העובדה שהם עלולים להיות מוחלפים מדי שנה.

כמו כן, הצעה זו מאפשרת לוועדה להתכנס במהלך השנה ולאשר טכנולוגיות ללא תוספת עלות, ובכך תקצר את פרק הזמן הנדרש עד שטכנולוגיות אלו יוכלו לעמוד לרשות ציבור החולים – נעיר כי לפי דוח מבקר המדינה משנת 2022, כ-31% מהטכנולוגיות הנוספות לסל מידי שנה, נוספות לסל ללא תוספת עלות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)